



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG

Terakreditasi B (Baik Sekali) BAN - PT

Program Studi :

1. Diploma III Kebidanan
2. Sarjana Keperawatan
3. Profesi Ners
4. Sarjana Gizi
5. Sarjana Kebidanan
6. Pendidikan Profesi Bidan

Alamat : Jl. Veteran Mancar Peterongan Jombang Telp./Fax. 0321 - 877025

Jombang, 07 Oktober 2025

Nomor : 314/SHJ/S.Pend/X/2025

Kepada,-

Lampiran : -

Yth. Direktur RS Prima Husada Sukorejo

Perihal : Pengantar Studi Pendahuluan
Penelitian

Di -

TEMPAT

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir berupa Skripsi bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Husada Jombang Tahun Akademik 2025/ 2026, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : **SELA DIANTI AYU PUTRI**

NIM : 2024 03 0317

Prodi : Sarjana Keperawatan STIKes Husada Jombang

Tempat Penelitian : Di Ruang IRNA 2B RS Prima Husada Sukorejo

Bersama ini kami mohon agar mahasiswa termaksud mendapatkan ijin dan kesempatan melakukan studi pendahuluan serta diberikan data - data yang berkaitan dengan Penelitian dengan judul "**EDUKASI KESEHATAN TENTANG LUKA TERHADAP SIKAP PENCEGAHAN DEKUBITUS PADA KELUARGA PASIEN DENGAN CVA INFARK**".

Demikian atas bantuan dan kebijakannya di sampaikan ucapan terima kasih.

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Husada Jombang



Dr. Hany Puspita Aryani, dr., MM., M.Kes.

NIPR. 010801059

PROPOSAL

EDUKASI KESEHATAN TENTANG LUKA TERHADAP SIKAP PENCEGAHAN DEKUBITUS PADA KELUARGA PASIEN DENGAN CVA INFARK



OLEH:

SELA DIANTI AYU PUTRI

NIM: 2024030317

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI KESEHATAN HUSADA JOMBANG
2025**

PROPOSAL

EDUKASI KESEHATAN TENTANG LUKA TERHADAP SIKAP PENCEGAHAN DEKUBITUS PADA KELUARGA PASIEN DENGAN CVA INFARK



OLEH:

SELA DIANTI AYU PUTRI

NIM: 2024030317

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI KESEHATAN HUSADA JOMBANG
2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya Bersumpah Bahwa Proposal Ini Adalah Hasil Karya Sendiri Dan Belum Pernah Dikumpulkan Oleh Orang Lain Untuk Memperoleh Gelar Dari Berbagai Jenjang Di Perguruan Tinggi Manapun. Saya siap menyerahkan Softcopi untuk keperluan institusi baik kepengarangan atau publikasi

Jombang,.....2025

Yang Menyatakan

Sela Dianti Ayu Putri
NIM: 2024030317

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal ini telah di konsulkan dan siap dipresentasikan dan dipertanggung
jawabkan pada sidang Proposal pada.

Hari :.....

Tanggal :.....

Oleh
Pembimbing I

Asri Kusyani, S Kep., Ns., M.Kep
NPP: 011 305 136

Pembimbing II

Fahrur Rozi, S.Kep., Ns., M.Kep
NPP: 010906068

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Proposal telah diuji dan di tetapkan

Pada Tanggal :

PANITIA PENGUJI

Ketua : Najah Soraya Niah.S.Sos., MM : (.....)
NPP: 010406018

Anggota I : Asri Kusyani, S.Kep., Ns., M.Kep : (.....)
NPP: 011305108

Anggota II : Fahrur Rozi, S.Kep., Ns., M.Kep : (.....)
NPP: 010906068

Mengetahui
Ketua STIKES Husada
Jombang

Ka. Prodi S1 Keperawatan STIKES
Husada Jombang

Dra. Hj. Soelijah Hadi, M.Kes., MM
NPP : 010201001

Sylvie Puspita, S. Kep., Ns., M.Kep
NPP : 011305103

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penelitian mampu menyelesaikan Proposal yang berjudul “Edukasi Kesehatan Tentang Luka Terhadap Sikap Pencegahan Dekubitus Pada Keluarga Pasien Dengan CVA Infark”. Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Proposal ini masih banyak kekurangan namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin sehingga dapat menyelesaikan, baik melalui konsultasi dengan pembimbing dan membaca berbagai jurnal/literatur. Oleh karena itu ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada:

1. Dra. Hj. Soelijah Hadi, M.Kes., MM, selaku Ketua STIKES Husada Jombang.
2. Sylvie Puspita, S. Kep., Ns., M.Kep selaku Kaprodi S1 Keperawatan STIKES Husada Jombang.
3. Pembimbing 1 adalah Asri Kusyani, S.Kep., Ns., M.Kep, saya berterimakasih atas bimbangannya.
4. Pembimbing 2 adalah Fahrur Rozi, S.Kep., Ns., M.Kep, saya berterimakasih atas bimbangannya.
5. Keluargaku tercinta yang selalu memancurkan cinta kasih sayang dan do'a-do'a dalam setiap langkahku.

Peneliti menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat masih terbatasnya ilmu dan pengalaman, oleh karena itu peneliti tidak menutup diri bila ada kritik dan saran yang bersifat membangun agar penyusunan proposal ini lebih sempurna di mas yang akan datang. Semoga penyusun proposal ini dapat bermanfaat dan berguna bagi profesi dan para pembacanya.

Jombang,.....2025

Sela Dianti Ayu Putri
NIM: 2024030317

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

CVA adalah suatu keadaan dimana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik fokal dan global. Penyakit yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian, tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain *vascular* (Ariyanti, 2024). Pasien CVA rentan terjadi luka pada bagian tubuh yang berbaring lama yaitu bagian punggung, bokong, dan pantat. Luka pada pasien yang berbaring lama disebut decubitus. Dekubitus merupakan luka pada kulit yang terlokalisasi atau pada jaringan dibawah tulang yang menonjol akibat tekanan yang terus-menerus atau tekanan yang disertai dengan gesekan (Agustini dkk., 2025). Upaya pencegahan terjadinya luka tekan sebaiknya dilakukan sedini mungkin sejak pasien teridentifikasi berisiko mengalami luka tekan (Rahayu dkk., 2024).

Prevalensi pasien stroke mengembangkan ulkus dekubitus derajat 1 (1,7%), derajat 2 (1,7%), derajat 3 (2,5%), dan derajat 4 (2,5%) sebagian besar di daerah sakral (6,7%) dan juga pada pergelangan kaki (0,8%), dan bahu (0,8%) masing-masing (Farid dkk., 2022). Angka insiden luka dekubitus di Indonesia mencapai 33,3%, dimana angka ini cukup tinggi dibandingkan dengan prevalensi ulkus dekubitus di Asia Tenggara (Meikasari dkk., 2024). Prevalensi insiden kejadian ulkus decubitus pada pasien CVA di Jawa Timur yaitu 53% (Apyanto & Satiti, 2023). Data pasien decubitus yang di dapat di rumah sakit Prima Husada Sukorejo dari bulan Juni-Agustus 42 pasien (Rekam Medis RS Prima Husada, 2025).

Terdapat dua tipe utama dari stroke yaitu stroke iskemik/non hemoragik pendarahan akibat berkurangnya aliran darah sehubungan dengan penyumbatan, dan hemoragik akibat perdarahan. Stroke terjadi akibat pembuluh darah yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyumbatan dan ruptur, kekurangan oksigen menyebabkan fungsi kontrol gerakan tubuh yang dikendalikan oleh otak tidak berfungsi. Pasien CVA mengalami tirai baring yang lama. Dari tirai baring yang lama dapat mengakibatkan terbentuknya luka dekubitus (Ariyanti, 2024). Dampak yang muncul akibat ulkus dekubitus antara lain dampak terhadap kondisi fisik, sosial, psikologis, finansial, dampak yang diakibatkan dari gejala ulkus dekubitus, dan dampak terhadap kesehatan secara umum (Nurhaida, 2022). Dekubitus yang dialami pasien CVA yang tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi, sepsi yang mengancam jiwa, nyeri kronis, kanker kulit, fistula terbentuknya saluran abnormal, kontraktur sendi, anemia, depresi, dan penurunan kualitas hidup (Andriyanto dkk., 2024).

Pencegahan terjadinya komplikasi pada dekubitus dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan keluarga dalam pencegahan dekubitus perlu dilaksanakan sosialisai dan penyuluhan edukasi kesehatan (Ariyanti, 2024). Edukasi kesehatan yang diberikan kepada keluarga bermanfaat untuk perawatan di rumah dan meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan dekubitus (Nurhaida, 2022).

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Irianto dkk (2019) bahwa hasil gambaran pendidikan kesehatan pada keluarga pasien stroke terhadap pencegahan dekubitus berada pada kategori baik dengan hasil 74%. Peneliti

terdahulu yang dilakukan oleh Nurhaida (2022) bahwa hasil penelitiannya dari 30 pengetahuan keluarga yang menjawab Tidak sebanyak sebanyak 11 responden (36,7%) dan menjawab Ya sebanyak 19 responden (63,3%).

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul “Edukasi Kesehatan Tentang Luka Terhadap Sikap Pencegahan Dekubitus Pada Keluarga Pasien Dengan CVA Infark”.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Penyakit CVA merupakan gangguan suplai darah ke otak karena ada perdarahan atau sumbatan. Pasien CVA mengalami kelemahan otot sebagian, sehingga disarankan bedres total. Bedres total pada pasien CVA dapat mengakibatkan dekubitus dibagian tekanan. Dekubitus terjadi karena pasien terlalu lama berbaring tidak dilakukan miring kanan dan kiri atau digerakkan anggota badannya. Pencegahan untuk pasien dekubitus ini dilakukan edukasi kesehatan agar keluarga mengetahui tentang pencegahan terjadinya luka dekubitus.

1.2.2 Pertanyaan Peneliti

Bagaimana Edukasi Kesehatan Tentang Luka Terhadap Sikap Pencegahan Dekubitus Pada Keluarga Pasien Dengan CVA Infark?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui edukasi kesehatan tentang luka terhadap sikap pencegahan dekubitus pada keluarga pasien dengan CVA Infark.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi edukasi kesehatan tentang luka terhadap sikap pencegahan dekubitus pada keluarga pasien dengan CVA Infark.
2. Mengetahui edukasi kesehatan tentang luka terhadap sikap pencegahan dekubitus pada keluarga pasien dengan CVA Infark.

1.4 Manfaat

1. Bagi Pasien

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pasien CVA agar keluarga dapat mencegah luka dekubitus.

2. Bagi Insititusi Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja tim promosi keshatan rumah sakit RS Prima Husada Sukorejo tentang edukasi kesehatan tentang luka terhadap sikap pencegahan dekubitus pada keluarga pasien dengan CVA Infark.

3. Bagi Insititusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, bahan pertimbangan, acuan, dan sumber data penelitian tentang edukasi kesehatan tentang luka terhadap sikap pencegahan dekubitus pada keluarga pasien dengan CVA Infark.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan pengetahuan dan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang edukasi kesehatan tentang luka terhadap sikap pencegahan dekubitus pada keluarga pasien dengan CVA Infark.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep CVA Infark

2.1.1 Pengertian CVA Infark

CVA (*Cerebri Vascular Accident*) adalah kelainan fungsi otak. Onset mendadak yang disebabkan oleh gangguan sirkulasi darah otak dan dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja dengan gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebabkan cacat dalam bentuk kelumpuhan anggota badan, gangguan bicara, proses berpikir, memori dan bentuk kecacatan lainnya menyebabkan kematian (Tunik dkk., 2022). CVA infark merupakan kondisi serius ketika aliran darah ke otak terhambat atau tersumbat, sehingga sel-sel otak tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi, yang menyebabkan kerusakan jaringan (infark) dan kematian sel (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

2.1.2 Penyebab CVA Infark

Penyebab CVA infark menurut Tunik dkk (2022) antara lain:

1. Trombosis Serebral

Trombosis ini terjadi karena berkurangnya kelenturan atau elastisitas pembuluh darah (arterosklerosis), sehingga mengalami oklusi dan menyebabkan iskemi pada jaringan otak, menimbulkan oedema, dan kongesti di sekitarnya. Trombosis biasanya terjadi pada orang tua sedang tidur atau bangun tidur. Hal ini dapat terjadi

karena penurunan aktivitas simpatik dan penurunan darah yang menyebabkan iskemik serebral.

2. Emboli

Emboli serebral merupakan penyumbatan pembuluh darah otak oleh karena bekuan darah, lemak, dan udara. Pada umumnya emboli berasal dari thrombus yang terlepas dan menyumbat arteri serebral.

2.1.3 Manifestasi Klinis CVA Infark

Manifestasi klinis CVA infark adalah memiliki tanda khas TIA yang kehilangan fungsi fokal SSP secara mendadak, gejala seperti sinkop. Bingung, dan pusing tidak cukup untuk menegaskan diagnosis. TIA umumnya berlangsung selama beberapa selama beberapa menit saja, jarang berjam-jam. Gejala yang dialami daerah arteri yaitu gejala Karotis seperti hemiparesis, hilangnya sensasi (hemisensorik, disfasia, kebutaan monocular (*amaurosis fugax*)) yang disebabkan oleh iskemia retina. Vertebrobasilar seperti pareis atau hilangnya sensasi bilateral atau alternatif, kebutaan mendadak bilateral (pada pasien usia lanjut), diplopia, ataksia, vertigo, disfagia, setidaknya dua dari tiga gejala ini terjadi secara bersamaan (Kusyani & Khayudin, 2021).

2.1.4 Komplikasi CVA Infark

Komplikasi CVA infark menurut Nelty (2023) antara lain:

1. Gumpalan darah (thrombosis vena dalam atau emboli paru).
2. Infeksi saluran kemih.
3. Masalah usus dan kandung kemih.

4. Kelemahan otot.
5. Dekubitus.
6. Masalah mobilitas dan jatuh.

2.1.5 Pemeriksaan Penunjang CVA Infark

Pemeriksaan penunjang CVA infark yang dianjurkan segera dilakukan pada setiap pasien CVA infark meliputi pemeriksaan CT-*scan* tanpa komtras, kadar gula darah, elektrolit serum, tes fungsi ginjal, EKG, penanda iskemik jantung, hitung darah lengkap, PT/INR, aPTT, fibrinogen, pemeriksaan tes fungsi, toksikologi, kadar alkohol dalam darah, tes kehamilan, analisis gas darah, dan foto rontgen toraks (Neltty, 2023).

2.1.6 Penatalaksanaan CVA Infark

Pada terapi CVA infark ada dua terapi menurut Agustien dkk (2025) antara lain:

1. Antitrombotik digunakan mencegah pembentukan bekuan darah baru yang dapat tersangkut di arteri otak dan menyebabkan stroke.
2. Trombolitik untuk mengobati stroke dengan melarutkan bekuan darah yang menghalangi aliran darah ke otak.

2.2 Konsep Luka Dekubitus

2.2.1 Definisi Luka Dekubitus

Luka dekubitus adalah cedera terlokalisasi pada kulit atau jaringan di bawahnya biasanya diatas tonjolan tulang, akibat ada tekanan, atau kombinasi dari tekanan dan robekan. Terdapat tekanan atau gesekan pada kulit terus-menerus, sehingga menyebabkan suplai darah yang menuju

kulit terputus dan jaringan menjadi mati (Rajagukguk, 2024). Luka dekubitus adalah cedera lokal pada kulit atau jaringan bawah kulit yang terjadi karena tekanan atau tekanan bersama gesekan, biasanya di atas area tulang yang menonjol (WHO, 2022).

2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Luka Dekubitus

Penyebab luka dekubitus menurut Rajagukguk (2024) antara lain:

1. Intensitas Tekanan

Intensitas tekanan merupakan tekanan antar muka kulit bagian luar dengan permukaan kasur. Dimana jika tekanan antar muka melebihi tekanan kapiler akan kolaps sehingga jaringan akan mengalami hipoksia dan dapat menyebabkan terjadinya iskemia.

2. Durasi Tekanan

Luka tekan dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan antara waktu dan tekanan. Semakin besar tekanan serta durasinya, maka semakin tinggi insiden luka tekan. Kulit dan jaringan sub kutan dapat mentoleransi beberapa tekanan, namun pada tekanan eksternal yang besar dan melebihi dari tekanan kapiler dapat menurunkan aliran darah ke jaringan sekitarnya, jika tekanan dihilangkan pada saat sebelum titik kritis maka sirkulasi ke jaringan tersebut akan kembali pulih.

3. Mobilitas dan Aktivitas

Mobilitas adalah kemampuan untuk mengubah dan mengontrol posisi tubuh, sedangkan aktivitas adalah kemampuan untuk berpindah. Pasien yang berbaring terus-menerus di tempat

tidur tanpa mampu untuk merubah posisi berisiko tinggi terjadi luka tekan. Imobilitas merupakan faktor yang paling signifikan terhadap kejadian luka tekan secara langsung berhubungan dengan lamanya imobilitas.

4. Gerakan dan Robekan

Gesekan merupakan tekanan yang diberikan pada kulit dengan arah paralel terhadap permukaan tubuh. Gaya ini terjadi saat pasien bergerak atau memperbaiki posisi tubuhnya di atas tempat tidur. Gaya robekan merupakan gaya ditimbulkan sebagai interaksi antara gaya gravitasi dan gesekan. Gravitasi membuat tubuh senantiasa tertarik ke bawah sehingga menimbulkan gerakan yang merosot.

Gaya robekan akan diperparah oleh kondisi permukaan matras yang keras dan kasar, linen yang kusut dan lembab atau pakaian pasien basah. Dengan adanya gaya robekan, maka jaringan akan saling menekan, pembuluh darah teregang serta sirkulasi mikro dan subkutan terganggu. Sakrum dan tumit merupakan bagian yang rentan terhadap robekan.

5. Kelembaban

Penyebab menurunnya toleransi jaringan yang paling sering ditemukan adalah kelembaban yang disebabkan oleh urine dan feses pada pasien inkontinensia bisa mengakibatkan terjadinya maserasi pada jaringan kulit. Selain itu kelembaban juga mengakibatkan kulit mudah terjadi pergesekan dan perobekan terhadap jaringan.

6. Persepsi Sensori yang Menurun

Pasien yang tidak mampu merasakan sensasi, mengkomunikasikan persepsi nyeri yang dirasakan akibat tekanan cenderung akan mengalami terjadinya luka tekan. Pada pasien dengan gangguan status mental oleh karena stroke, injury, alzheimers disease atau masalah kognitif lainnya sangat berisiko untuk terjadinya luka tekan.

7. Gangguan NUtrisi

Peranan nutrisi sangat penting dalam proses penyembuhan luka dan perkembangan pembentukan luka tekan. Nutrien yang berperan dalam menjaga toleransi jaringan adalah protein, vitamin A, C, E dan zinc. Protein sangat berperan sebagai regenerasi jaringan, sistem imunitas dan reaksi inflamasi. Kurangnya protein dapat meningkatkan kecenderungan edema yang mengganggu suatu transportasi oksigen dan nutrien ke jaringan.

Pasien dengan nutrisi buruk yang diakibatkan oleh kekurangan protein dapat mengakibatkan jaringan lunak mudah rusak. Nutrisi yang buruk juga berhubungan dengan keseimbangan cairan dan elektrolit. Kekurangan protein akan mengakibatkan edema atau sembab sehingga mengganggu distribusi oksigen dan transportasi nutrien.

8. Usia

Usia mempengaruhi perubahan pada kulit. Dimana proses menua mengakibatkan perubahan struktur kulit menjadi lebih tipis dan mudah rusak. Usia lanjut atau 60 tahun ke atas mengalami luka

tekan. Pada usia lanjut atau lebih dari 60 tahun dapat dihubungkan dengan perubahan-perubahan seperti menipisnya kulit, kehilangan jaringan lemak, menurunnya fungsi persepsi sensorik, meningkatnya fragilitas pembuluh darah. Kombinasi perubahan karena proses menua dan faktor lain menyebabkan kulit mudah rusak jika mengalami tekanan, robekan, dan gesekan.

9. Merokok

Merokok merupakan prediktor terbentuknya luka tekan dikarenakan afinitas hemoglobin dengan nikotin dan meningkatnya radikal bebas yang diduga sebagai penyebab risiko terbentuknya luka tekan pada perokok.

10. Peningkatan Suhu Tubuh

Kejadian luka tekan juga dipengaruhi oleh suhu tubuh. Hal ini dapat terdapat terjadi dengan meningkatnya suhu tubuh 1°C akan meningkatkan kebutuhan metabolisme jaringan sebesar 10%. Peningkatan metabolisme ini akan meningkatkan konsumsi oksigen dan kebutuhan energi pada tingkat sel termasuk pada daerah yang mendapat tekanan sehingga kerusakan jaringan akan semakin cepat terjadi. Peningkatan suhu tubuh dapat mengaktifkan kelenjar keringat sehingga meningkatkan kelembaban pada permukaan kulit.

11. Status Psikologi

Peningkatan hormon kortisol yang disebabkan oleh stress dihubungkan dengan ketidakseimbangan degradasi kolagen dengan pembentukan kolagen yang selanjutnya mengalami kehilangan

kolagen yang dihubungkan dengan perkembangan luka tekan pada pasien, biasanya terjadi pada pasien dengan cedera tulang belakang. Dampak lain dari stress juga dapat meningkatkan sekresi glukokortikoid yang dihubungkan dengan peranan hormon tersebut dalam metabolisme beberapa zat seperti karbohidrat, protein serta lemak yang menjadi penyokong integritas kulit dan jaringan pendukungnya.

2.2.3 Klasifikasi Luka Dekubitus

Klasifikasi luka decubitus menurut Rajagukguk (2024) antara lain:

1. Grade I

Kulit kemerahan (erythema), dan muncul bila ditekan oleh jari. Menandakan adanya gangguan sirkulasi. Kelainan terbatas pada epidermis dan dermis saja. Pasien mulai merasakan nyeri lokal. Kondisi ini reversible, dengan hilangkan tekanan. Penyembuhan total 5-10 hari, kenali fase ini dengan benar, agar segera dicegah efek lanjut.

2. Grade II

Timbul excoriasi (abrasi/lecet) kulit, blister, menyertai erythema. Pada fase ini, dekompresi tidak memberi hasil pemulihan. Pada grade II akhir, terjadi nekrosis superfisialis. Lapisan adipose ikut terganggu. Luka difase ini masih dapat reversible.

3. Grade III

Ulkus sudah mencapai seluruh lapisan kulit dan meluas ke lemak subkutaneus, tetapi belum sampai ke otot. Tanda-tanda inflamasi

jelas, edema, sering terjadi infeksi. Tepi ulkus irreguler dan terjadi hipoglikemia, hiperglikemia pigmentasi, sering diikuti tanda-tanda iskemik seperti demam, leukosit, dehidrasi, dan anemia

4. Grade IV

Pada stadium keempat seluruh ketebalan kulit dan jaringan dibawahnya rusak. Cedera tersebut melibatkan struktur dalam otot tulang, fasia, tendon, atau tulang rawan. Jaringan fibrinosa atau nekrotik bisa saja terjadi.

2.2.4 Upaya Luka Dekubitus

Upaya luka dekubitus menurut Rajagukguk (2024) antara lain:

1. Mengatur posisi yang tepat untuk mencegah terjadinya friksi.
2. Mengubah posisi setiap tiap 2 jam. Perubahan posisi tiap 2 jam disini termasuk sewaktu penderita tidur. Pada kasus-kasus tertentu, jarak waktu 2 jam masih mempunyai risiko terjadinya dekubitus.
3. Nutrisi yang baik.
4. Perawatan dan kebersihan yang baik.
5. Waspada terhadap daerah-daerah yang mempunyai risiko tinggi terbentuknya dekubitus.

2.3 Konsep Sikap

2.3.1 Pengertian`Sikap

Sikap manusia merupakan prediktor yang utama dalam kehidupan sehari hari. Hal ini menunjukkan, bahwa kemungkinan sikap dapat menentukan tindakan seseorang, tetapi kemungkinan juga sikap tidak terwujud menjadi sebuah tindakan (Latifah, 2023). Sikap dalam konteks

kesehatan adalah kecenderungan individu atau keluarga untuk menerima, menolak, atau merespons intervensi kesehatan berdasarkan nilai dan keyakinan yang dimiliki (World Health Organization, 2022).

2.3.2 Faktor Sikap

Faktor sikap menurut Latifah (2023) antara lain:

1. Pengalaman

Pengalaman yang kita alami akan menyebabkan serta memengaruhi cara kita menilai hal-hal dalam kehidupan sosial.

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Orang-orang yang kita anggap penting, yang memiliki peran signifikan dalam hidup kita, memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana kita memandang dan merespons berbagai aspek sosial.

3. Pengaruh kebudayaan

Budaya di lingkungan tempat kita tinggal memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan dan sikap kita. Jika budaya kita mendorong toleransi terhadap hubungan heteroseksual yang beragam, maka kita cenderung mendukung kebebasan dalam hal tersebut.

4. Media massa

Media massa, seperti televisi, radio, dan publikasi lainnya, memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini dan keyakinan orang. Media memainkan peran penting dalam membentuk sikap kita terhadap banyak masalah sosial.

5. Pengaruh faktor emosional

Sikap kita sering kali didasarkan pada emosi, seperti rasa frustrasi atau kepuasan. Emosi ini dapat menjadi bagian dari mekanisme pertahanan ego yang membentuk sikap kita.

2.3.3 Ciri-Ciri Sikap

Ciri-ciri sikap menurut Latifah (2023) antara lain:

1. Sikap bukanlah sesuatu yang sudah ada sejak lahir, melainkan sesuatu yang terbentuk dan dipelajari selama perkembangan seseorang sehubungan dengan berbagai objek.
2. Sikap sesuatu yang dapat mengalami perubahan, sehingga seseorang dapat mempelajari sikap baru dan mengubah sikap yang sudah ada jika situasi atau kondisi tertentu menciptakan peluang untuk perubahan tersebut.
3. Sikap selalu terkait dengan suatu objek atau hal tertentu. Dengan kata lain, sikap seseorang terhadap suatu objek dapat menjadi jelas dan konsisten, bisa dipelajari, atau bahkan berubah seiring waktu.
4. Objek yang dimaksud dalam konteks sikap bisa berupa hal-hal yang spesifik atau bisa juga mencakup sekelompok hal atau aspek yang terkait.
5. Sikap memiliki dua komponen utama, yaitu komponen motivasi yang mencakup dorongan atau motivasi yang mendorong sikap, dan komponen sensori yang berhubungan dengan persepsi atau pengalaman sensori yang membedakan sikap dari keterampilan atau ilmu yang dimiliki seseorang.

2.3.4 Sifat Sikap

Sifat sikap menurut Latifah (2023) antara lain:

1. Sikap Positif

Sikap positif mencirikan keinginan seseorang untuk mendekati, menyukai, dan menantikan objek tertentu. Ini melibatkan perasaan positif, minat, dan kesiapan untuk terlibat atau berinteraksi dengan objek tersebut.

2. Sikap Negatif

Di sisi lain, sikap negatif mencerminkan kecenderungan seseorang untuk menghindari, menjauhi, merasa tidak suka, atau bahkan membenci beberapa objek. Ini melibatkan perasaan negatif, ketidakminatan, atau penolakan terhadap objek atau situasi tertentu

2.3.5 Komponen Pokok Sikap

Komponen pokok sikap menurut Latifah (2023) meliputi:

1. Keyakinan, gagasan serta konsep sehubungan dengan suatu objek berarti.
2. Kehidupan emosional dan konsep sehubungan dengan suatu objek yaitu cara evaluasi (mengukur unsur emosional) orang terhadap objek tersebut.
3. Cenderung bertindak lakuartinya sikap ialah komponen yang mendahului Tindakan atau tingkah laku yang diungkapkan.

2.3.6 Cara Pengukuran Sikap

Metode pengukuran langsung yang terstruktur dilakukan dengan cara menilai sikap melalui serangkaian pertanyaan yang telah

dirancang dengan baik dalam instrumen yang telah ditentukan, kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan langsung kepada subjek penelitian. Skala Likert alat yang digunakan untuk menilai sikap, pandangan, atau persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial tertentu. Jenis skala yang digunakan bisa beragam, termasuk skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, yang akan menghasilkan data dengan tingkat pengukuran yang sesuai, seperti data nominal, ordinal, interval, atau rasio (Latifah, 2023).

Berapa wujud jawaban dari pertanyaan atau pernyataan yang masuk dalam kategori skala *likert* sebagai berikut dengan pertanyaan sangat setuju nilai 4, setuju dengan nilai 3, tidak setuju nilai 2, dan sangat tidak setuju 1. Cara interpretasi dapat berdasarkan persentase sebagian berikut ini angka 0-20% sangat tidak setuju, angka 25-50% tidak setuju, angka 50-75% setuju, dan angka 75-100% sangat setuju (Latifah, 2023).

2.4 Konsep Edukasi Kesehatan

2.4.1 Pengertian Edukasi Kesehatan

Edukasi kesehatan merupakan intervensi keperawatan penting untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga dalam pencegahan komplikasi, termasuk luka tekan (WHO, 2022). edukasi kesehatan adalah strategi utama dalam *preventive care* yang efektif menurunkan kejadian luka tekan pada pasien berisiko tinggi (Abdelkader, 2023).

2.4.2 Tujuan Edukasi Kesehatan

Tujuan edukasi Kesehatan menurut Abdelkader (2023) antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan keluarga/pasien tentang risiko luka decubitus.
2. Membentuk sikap positif keluarga/petugas dalam melakukan pencegahan luka.
3. Mendorong perilaku nyata dalam tindakan pencegahan (reposisi, menjaga kebersihan, pemberian nutrisi).
4. Mengurangi angka kejadian luka dekubitus pada pasien dengan imobilitas, seperti stroke, trauma, atau pasca operasi.

2.4.3 Manfaat Edukasi Kesehatan

Manfaat edukasi kesehatan menurut McKenna dkk (2025) antara lain:

1. Edukasi kesehatan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga mengenai penyakit serta cara pencegahannya.
2. Edukasi mampu membentuk sikap positif keluarga dalam perawatan dan pencegahan komplikasi.
3. Edukasi mendorong terjadinya perubahan perilaku sehat, seperti reposisi pasien, menjaga kebersihan kulit, dan pemenuhan nutrisi.
4. Edukasi terbukti menurunkan angka kejadian luka dekubitus pada pasien dengan risiko tinggi.
5. Edukasi kesehatan meningkatkan kualitas hidup pasien serta mengurangi beban biaya perawatan jangka Panjang.

2.4.4 Metode Edukasi Kesehatan

Metode edukasi kesehatan menurut Abdelkader (2023) antara lain:

1. Metode Pendekatan Perorangan atau Individu

Metode yang bersifat individual dan biasanya digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi, metode ini dapat berupa bimbingan dan penyuluhan serta wawancara.

2. Metode Pendekatan Kelompok Kecil atau Kelompok Besar

Kelompok kecil adalah kelompok kecil adalah apabila peserta penyuluhan kurang dari lima orang. Metode yang digunakan untuk kelompok kecil seperti diskusi kelompok, curah pendapat (brainstorming), bola salju (snowballing), kelompok-kelompok kecil (buzz group), bermain peran (role play) dan permainan simulasi (simulation game). Kelompok besar adalah apabila peserta penyuluhan lebih dari lima orang. Metode yang baik digunakan untuk kelompok besar adalah ceramah dan seminar.

3. Metode Pendekatan Massa

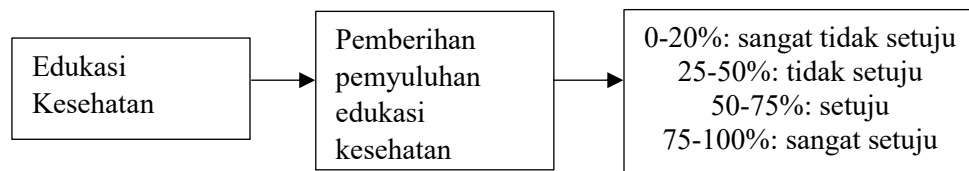
Metode pendekatan massa bentuk metode pendidikan massa yang digunakan seperti ceramah umum, pidato/diskusi. Metode pendekatan massa ini cocok untuk mengkomunikasikan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Metode ini bersifat umum, dalam arti tidak membedakan golongan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan sebagainya, sehingga pesan-pesan kesehatan yang ingin disampaikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap oleh massa.

2.5 Hubungan

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HEPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yaitu uraian konseptual mengenai hubungan antar konsep atau variabel yang disusun berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, serta pengalaman peneliti, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti (Nursalam, 2020).



Gambar 3.1 Kerangka Edukasi Kesehatan Tentang Luka Terhadap Sikap Pencegahan Dekubitus Pada Keluarga Pasien Dengan CVA Infark

Keterangan:

: Diteliti

Pasien dengan Cerebrovascular Accident (CVA) infark atau stroke non-hemoragik memiliki risiko tinggi mengalami imobilisasi jangka panjang. Kondisi imobilisasi ini dapat menimbulkan komplikasi berupa luka dekubitus akibat tekanan berkepanjangan pada area tubuh tertentu. Edukasi kesehatan merupakan intervensi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif, dan mendorong perubahan perilaku dalam perawatan pasien. Dengan pemberian edukasi kesehatan tentang luka dekubitus, diharapkan terjadi perubahan sikap keluarga menjadi lebih positif dalam pencegahan luka, sehingga risiko komplikasi pada pasien stroke dapat ditekan.

3.2 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka konseptual tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

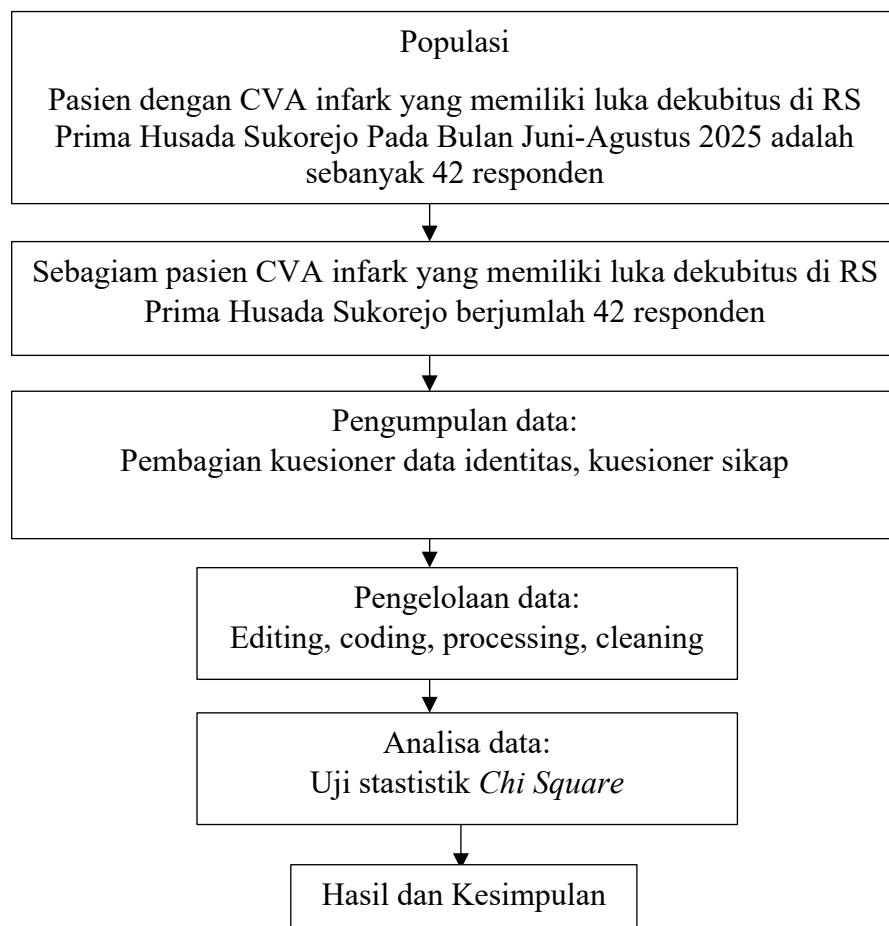
H1: ada edukasi kesehatan tentang luka terhadap sikap pencegahan dekubitus pada keluarga pasien dengan CVA infark.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Studi observasional dengan desain analisis *corelasional* dilakukan untuk mengetahui edukasi kesehatan tentang luka terhadap sikap pencegahan dekubitus pada keluarga pasien dengan CVA infark. Penelitian *cross sectional* berarti penelitian ini dilakukan dalam satu waktu guna menentukan faktor apa yang terjadi sebelum atau bersama-sama tanpa adanya suatu intervensi (Nursalam, 2020).

4.2 Kerangka Kerja



4.1 Gambar Kerangka Kerja Edukasi Kesehatan Tentang Luka Terhadap Sikap Pencegahan Dekubitus Pada Keluarga Pasien Dengan CVA Infark

4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

4.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien dengan CVA infark yang memiliki luka dekubitus di RS Prima Husada Sukorejo sebanyak 42 responden.

4.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang digunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Jumlah sampel sebanyak 42 responden.

4.3.3 Teknik Sampling

Teknik sampling pada penelitian ini adalah *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi. Artinya, semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian (Nursalam, 2020).

4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

4.4.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau diduga menjadi penyebab perubahan pada variabel lain (Sugiyono, 2020). Variabel bebas (*independent*) dalam penelitian ini adalah edukasi kesehatan.

4.4.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini merupakan hasil atau efek dari perlakuan

atau intervensi yang diberikan peneliti (Sugiyono, 2020). Variabel terikat (*dependent*) pada penelitian ini sikap pencegahan luka.

4.4.3 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Parameter	Alat Ukur	Skala	Skoring dan Kriteria
Independen: Edukasi kesehatan dekubitus	Proses pemberian informasi terstruktur kepada keluarga pasien CVA Infark mengenai luka dekubitus, meliputi pengertian, faktor risiko, tanda-tanda awal, pencegahan, dan perawatan dasar, dengan metode ceramah, diskusi, dan leaflet.	1. Materi edukasi tersampaikan (pengertian, faktor risiko, tanda awal, pencegahan, perawatan dasar). 2. Media edukasi (leaflet, ceramah) digunakan. 3. Partisipasi keluarga (bertanya/menjawab). 4. Waktu edukasi sesuai jadwal.	Lembar observasi pelaksanaan edukasi (materi, media, waktu, metode).	Nominal	1: Edukasi diberikan 0: Edukasi tidak diberikan
Dependen: Sikap pencegahan luka	Respon internal penderita terhadap upaya pencegahan luka dekubitus pada pasien CVA Infark, yang mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), dan konatif (tindakan).	Kognitif: Mengetahui pengertian, faktor risiko, tanda awal dekubitus. Afektif: Menunjukkan kepedulian, kesadaran pentingnya pencegahan. Konatif: Kesiediaan melakukan reposisi, menjaga kebersihan kulit, memberi nutrisi pasien.	Kuesioner sikap pencegahan dekubitus dengan skala Likert	Ordinal	1. 0-20% sangat tidak setuju 2. 25-50% tidak setuju 3. 50-75% setuju 4. 75-100% sangat setuju

4.5 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan adalah laptop, kuesioner, dan bulpen.

4.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah untuk mengukur sikap pencegahan luka kuesioner *skala likert* dan kuesioner data responden. Pengukuran sikap yaitu *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijelaskan menjadi indicator variabel. Kemudian indicator variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan.

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di rumah sakit Prima Husada Sukorejo. Keluarga pasien mengisi data diri pasien dan kuesioner skala likrt. Setelah itu dilakukan penyuluhan edukasi kesehatan mengenai pencegahan luka dekubitus. Penelitian dilakukan selama 3 hari, hari pertama 15 responden, hari kedua 14 responden dan hari ketiga 13 responden.

4.8 Prosedur Pengambilan Data

Langkah-langkah pengambilan data pada penelitian ini adalah:

1. Peneliti mengajukan surat perizinan penelitian dari insitusi Pendidikan program studi S1 Keperawatan STIKes Husada Jombang.
2. Melakukan uji laik etik di STIKes Husada Jombang dan telah diterbit sertifikat laik etik.
3. Peneliti mengajukan surat permohonan izin penelitian ke pihak SDM rumah sakit Prima Husada Sukorejo.

4. Setelah melakukan pengajuan permohonan izin penelitian, peneliti mengambil data di rumah sakit Prima Husada Sukorejo.
5. Melakukan teknik penentuan sampel total sampling.
6. Peneliti bertemu dengan responden.
7. Responden dan keluarga responden yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian, peneliti sebelumnya akan menanyakan terkait kemampuan responden dalam pengisian kuesioner.
8. Responden yang bersedia, bisa membaca dan menulis maka peneliti memberikan lembar kuesioner kepada responden.
9. Jika responden bersedia namun tidak bisa membaca dan menulis maka boleh diwakilkan oleh pendamping keluarga yang menunggu responden.
10. Setelah itu dilakukan penyuluhan edukasi kesehatan pencegahan luka dekubitus.
11. Lembar kuesioner yang telah diisi oleh responden dikumpulkan oleh peneliti untuk kemudian dilakukan analisa. Data yang diambil adalah data primer yaitu hasil dari mengisi kuesioner.

4.9 Cara Analisa Data

Analisa data dilakukan menggunakan *software computer* yaitu *Statistical Product and Solution* (SPSS) versi 25.0 dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *chi-square* untuk mengetahui prosentasi distribusi antar variabel, jika uji statistik menunjukkan $p < 0,05$ maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel. Jika arah korelasi positif (+) menunjukkan arah hubungan positif yang berarti variabel dependen tinggi maka variabel independen juga tinggi. Sedangkan, tanda negatif (-) menunjukkan arah

hubungan negatif $p < 0,05$ yang berarti jika variabel dependen tinggi maka variabel independen akan turun dan sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui edukasi kesehatan tentang luka terhadap sikap pencegahan dekubitus pada keluarga pasien dengan CVA infark.

4.10 Masalah Etik

Penelitian ini telah diajukan kepada komite etik penelitian tentang edukasi kesehatan tentang luka terhadap sikap pencegahan dekubitus pada keluarga pasien dengan CVA infark. Penelitian harus memperhatikan beberapa prinsip etik yang harus peneliti junjung tinggi kepada responden penelitian diantaranya (Nursalam, 2020):

1. Persetujuan Responden (*Informed Consent*)

Informed consent adalah bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan. Tujuan informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian serta mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan. Sebaliknya jika tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak pasien. Informasi yang ada pada lembar persetujuan ialah partisipasi pasien, tujuan dilakukannya tindakan, prosedur pelaksanaan, potensial masalah yang akan terjadi, manfaat, dan kerahasiaan.

2. Tanpa Nama (*Anonymity*)

Masalah etika keperawatan merupakan masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak

memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar pengkajian dan hanya menuliskan kode atau inisial pada lembar pengumpulan data serta hasil penelitian yang akan disajikan.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan merupakan etika penelitian dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian serta hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.

4. Manfaat (*Beneficence*)

Prinsip etik beneficence dalam penelitian adalah kewajiban membantu orang lain dengan mengupayakan manfaat maksimal dan kerugian minimal. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan intervensi untuk memberikan manfaat kepada responden.

4.11 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Jumlah sampel yang terbatas dan hanya berasal dari satu fasilitas pelayanan kesehatan menyebabkan hasil penelitian ini kurang dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap berupa kuesioner berisiko menimbulkan bias jawaban, karena responden cenderung memberikan jawaban yang dianggap baik secara sosial, sehingga mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan sikap yang sebenarnya. Intervensi edukasi diberikan dalam jangka waktu yang relatif

singkat sehingga efek yang terukur lebih bersifat jangka pendek, tanpa adanya tindak lanjut untuk menilai keberlanjutan sikap pencegahan dekubitus di rumah. Faktor-faktor luar seperti kondisi emosional keluarga, tingkat pendidikan, pengalaman merawat pasien, serta ketersediaan fasilitas pendukung juga menjadi variabel yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya dan berpotensi memengaruhi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelkader, M. (2023). *Effectiveness of structured health education in pressure ulcer prevention: A randomized controlled trial*. Journal of Wound Care.
- Agustien, R., Rahmawan, F. A., & Faidah, N. (2025). *Buku Asuhan Keperawatan Pasien Dengan Kegawatdaruratan Pada Sistem Persyarafan*. Mahakarya Citra Utama Group.
<https://books.google.co.id/books?id=vkBzEQAAQBAJ>
- Agustini, N. L. P. I. B., Susanti, N. P. A., Sri, N. K., Wahyuni, I., Israfil, I., & Indrayani, N. L. D. (2025). *Pemberdayaan Keluarga Berbasis Video Edukasi dalam Pencegahan dan Perawatan Dekubitus Pada Pasien Post Stroke di RSUD Kabupaten Klungkung*.
- Andriyanto, Armiyanti, Y., Aisyah, S., Samiasih, R. N. A., Pranata, S., Daryaswanti, P. I., & Rianty, E. (2024). *PROMENDEC : Intervensi mandiri keperawatan Mencegah terjadinya dekubitus pada pasien tirah baring*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=ijQWEQAAQBAJ>
- Apryanto, F., & Satiti, I. A. D. (2023). Kepuasan Perawat Terhadap Penggunaan Penilaian Dekubitus Berbasis Aplikasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14411–14421.
- Ariyanti, S. P. D. (2024). *STUDI KASUS PADA PASIEN DENGAN DIAGNOSA MEDIS CVA INFARK DI RS SWASTA BLITAR*.
- Farid, J., Amin, R., Sheikh, M. A., Irfan, M., AlRuwaili, R., Alruwaili, M., Ali, N. H., Albarrak, A. M., & Rahman, S. (2022). Prevalence and prediction of pressure ulcers in admitted stroke patients in a tertiary care hospital. *Journal of Tissue Viability*, 31(4), 768–775.
<https://doi.org/10.1016/j.jtv.2022.07.010>
- Irianto, I. D., Aisyah, S., Hasanah, I., & Wahyisah, F. (2019). Gambaran Edukasi Kesehatan Pada Keluarga Pasien Stroke Tentang Pencegahan Dekubitus. *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan*, 11(1), 4–4.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2021*. Kemenkes RI.
- Kusyani, A., & Khayudin, B. A. (2021). *ASUHAN KEPERAWATAN STROKE untuk mahasiswa dan perawat profesional*. GUEPEDIA.
<https://books.google.co.id/books?id=cO9ZEAAAQBAJ>
- Latifah, N. F. Q. (2023). *Sikap dengan Tindakan Pencegahan Ulkus Diabetikum (Di Dusun Mlilir, Desa Purwoasri, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)*.
- McKenna, H. P., Pajnkihar, M., & Vrbnjak, D. (2025). *Fundamentals of nursing models, theories and practice*. John Wiley & Sons.
- Meikasari, L., Silvitasari, I., & Waluyo, W. (2024). *PENERAPAN MASSAGE EFFLUGARE DENGAN VCO (VIRGIN COCONUT OIL) TERHADAP*

PENCEGAHAN DEKUBITUS PADA PASIEN TIRAH BARING DI RUANG ICU. *Indonesian Journal of Public Health*, 2(4), 698–708.

- Nelitty. (2023). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah: Asuhan Keperawatan pada Pasien Stroke, Meningitis, Tumor Otak, dan Cedera Kepala*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=8R-Seaaaqbaj>
- Nurhaida, Y. T. (2022). *HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERAN KELUARGA TERHADAP PENCEGAHAN LUKA DEKUBITUS PADA PENDERITA STROKE DI DESA BAKARAN BATU TAHUN 2022*.
- Nursalam. (2020). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis Edisi ke-5*. Salemba Medika.
- Rahayu, R., Hicanggi, R. N., & Sunarya, U. (2024). Gambaran Risiko Dekubitus pada Pasien Stroke di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Cimalaka. *JIKSA-Jurnal Ilmu Keperawatan Sebelas April*, 6(1), 34–37.
- Rajagukguk, A. (2024). *KARAKTERISTIK RESIKO LUKA TEKAN MENGGUNAKAN SKALA BRADEN PADA PASIEN DI RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH MEDAN*.
- Tunik, Anam, A. K., & Niningsih, R. (2022). *Perawatan Post Hospitalisasi: Pasien Stroke yang Mengalami Imobilisasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). <https://books.google.co.id/books?id=T1W3EAAAQBAJ>
- WHO. (2022). *Health promotion and disease prevention through population-based interventions, including action to address social determinants and health inequity*.
- World Health Organization. (2022). *Health promotion and behaviour change*. GENAVA.

LAMPIRAN

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Dengan Hormat,

Saya sebagai mahasiswa program studi S1 Keperawatan STIKes Husada Jombang:

Nama : Sela Dianti Ayu Putri

NIM : 2024030317

Judul : Edukasi Kesehatan Tentang Luka Terhadap Sikap Pencegahan

Dekubitus Pada Keluarga Pasien Dengan CVA Infark

Mengajukan dengan hormat kepada saudara/i untuk bersedia menjadi responden penelitian saya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Edukasi Kesehatan Tentang Luka Terhadap Sikap Pencegahan Dekubitus Pada Keluarga Pasien Dengan CVA Infark. Untuk itu saya mohon kesediaan untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan kerahasiaan responden dalam penelitian ini akan saya jamin.

Jombang,.....2025

Peneliti

(Sela Dianti Ayu Putri)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Kode:.....

Umur :

Alamat :

Setelah mendapatkan keterangan secukupnya serta mengetahui manfaat dan resiko penelitian yang berjudul Edukasi Kesehatan Tentang Luka Terhadap Sikap Pencegahan Dekubitus Pada Keluarga Pasien Dengan CVA Infark dengan sukarela menyetujui diikuti sertakan sebagai responden dalam penelitian ini, dengan catatan bila suatu waktu merasa dirugikan dalam bentuk apapun berhak membatalkan persetujuan ini. Saya percaya apa yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya.

Jombang,2025

Peneliti

Responden

(Sela Dianti Ayu Putri)

(.....)

Saksi/Keluarga

(.....)

DATA RESPONDEN

Kode Responden:.....

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia : tahun

Lama Penyakit:

Alamat :

No.Hp :

Jombang,.....2025

(.....)

LEMBAR KUESIONER
EDUKASI KESEHATAN TENTANG LUKA TERHADAP SIKAP
PENCEGAHAN DEKUBITUS PADA KELUARGA PASIEN
DENGAN CVA INFARK

No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Saya memahami bahwa pencegahan dekubitus adalah tanggung jawab utama perawat.				
2	Pencegahan dekubitus sama pentingnya dengan penanganan dekubitus itu sendiri.				
3	Pencegahan dekubitus dapat secara signifikan mengurangi biaya perawatan kesehatan.				
4	Saya teratur mengubah posisi pasien untuk mencegah penekanan kulit.				
5	Saya menggunakan bantal atau bantalan khusus untuk mengurangi tekanan pada area tonjolan tulang.				
6	Saya menjaga kebersihan dan kekeringan kulit pasien untuk mencegah gesekan.				
7	Saya memastikan pasien mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan kulit.				
8	Kurangnya waktu sering kali menjadi hambatan dalam melakukan tindakan pencegahan dekubitus.				
9	Keterbatasan sumber daya (seperti kasur anti-dekubitus) menghambat upaya pencegahan.				
10	Kurangnya pengetahuan atau pelatihan khusus tentang pencegahan dekubitus dapat menjadi masalah.				

Keterangan:

1. Pertanyaan

- Sangat setuju : 1
- Setuju : 2
- Tidak setuju : 3
- Sangat tidak setuju : 4

2. Interpretasi sebagai persentase

- Sangat tidak setuju : 0-20%

- Tidak setuju : 25-50%
- Setuju : 50-75%
- Sangat setuju : 75-100%

LEMBAR OBSERVASI KUESIONER SIKAP

[illegible]

Jadwal Penyusunan Skripsi Mahasiswa

Tahun Akademik 2025

NO	KEGIATAN	Juli 2025	Agustus 2025	September 2025	Oktober 2025	Novembrer 2025
1	PEMBAGIAN PEMBIMBING DAN BUKU PEDOMAN					
2	PENGAJUAN JUDUL					
3	STUDI PENDAHULUAN (SURAT PERMOHONAN)					
4	BAB 1					
5	BAB 2					
6	BAB 3					
7	BAB 4					
8	UJIAN PROPOSAL					
9	PELAKSANAAN PENELITIAN					
10	KONSUL HASIL PENELITIAN DAN PENDAAN					
11	PENYUSUNAN BAB 5					
12	BAB 6					
13	BAB 7					
14	KELENGKAPAN LAMPIRAN DAN SKRIPSI					
15	UJIAN HASIL SKRIPSI					
16	PENYERAHAN SKRIPSI					

SATUAN ACARA PENYULUHAN PENCEGAHAN LUKA DEKUBITUS

Tema : Pencegahan Luka Dekubitus

Hari,tanggal :

Waktu :

Tempat : Ruangan Irna 2B RS Prima Husada Sukorejo

Sasaran : Pasien dan keluarga pasien di kamar Irna 2B

1. Analisa Situasional

Penyuluhan : Mahasiswa S1 Keperawatan STIKes Husada Jombang

Peserta : Pasien dan keluarga pasien di kamar ruangan Irna 2B

2. Analisa Tujuan dan Karakteristik

a. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mendapatkan penyuluhan penyuluh berharap pasien dan keluarga pasien mampu memahami tentang cara mencegah luka dekubitus.

b. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mendapatkan penyuluhan keluarga mampu memahami:

1. Pengertian luka dekubitus
2. Penyebab luka dekubitus
3. Tanda dan gejala luka dekubitus
4. Pencegahan luka dekubitus

3. Lingkup Materi Pembelajaran

1. Pengertian luka dekubitus
2. Penyebab luka dekubitus
3. Tanda dan gejala luka dekubitus
4. Pencegahan luka dekubitus

4. Analisis Sumber Belajar

Materi terlampir

5. Strategi

1. Materi pembelajaran: ceramah dan diskusi
2. Media: leaflet

6. Kegiatan Penyuluhan

No	Waktu	Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Peserta
1	5 menit	Pembukaan 1. Membuka kegiatan dengan mengucap salam 2. Memperkenalkan diri 3. Menyampaikan tujuan penyuluhan 4. Menyebutkan materi yang akan disampaikan	Menjawab salam Mendengarkan Memperhatikan Memperhatikan
2	15 menit	Pelaksanaan 1. Pengertian luka dekubitus 2. Penyebab luka dekubitus 3. Tanda dan gejala luka dekubitus 4. Pencegahan luka dekubitus	Memperhatikan
3	10 menit	Evaluasi: membuka kesempatan diskusi	Bertanya dan menjawab pertanyaan
4	5 menit	Menyampaikan terimakasih atas kerjasamanya Mengucapkan salam penutup	Memperhatikan Menjawab salam

Lampiran 10 Materi Penyuluhan Pencegahan Luka Dekubitus

MATERI PENYULUHAN PENCEGAHAN LUKA DEKUBITUS

A. Definisi Luka Dekubitus

Luka dekubitus adalah kerusakan jaringan lokal pada bagian tubuh dengan permukaan tulang yang menonjol akibat tekanan, gesekan atau geseran dalam jangka waktu yang lama (WHO, 2022).

B. Penyebab Luka Dekubitus

1. Usia
2. Temperatur
3. Nutrisi
4. Tekanan
5. Gesekan dan geseran
6. Kelembapan
7. Imobilisasi
8. Keterbatasan aktivitas

C. Tanda dan Gejala Dekubitus

1. Luka dekubitus tahap I yaitu luka yang tidak memucat, bengkak, kemerahan, biru keabuan, dan melemahnya subkutan.
2. Luka dekubitus tahap II yaitu luka pada kulit epidermis dan dermis, lepuh, lubang yang dalam, terjadi nekrosis, edema dengan ekstrasvasi selular dan infiltrasi.
3. Luka dekubitus tahap III yaitu meluas sampai jaringan subkutan, ada lubang, dan tanpa erosi.
4. Luka dekubitus tahap IV yaitu meluas ke dalam struktur di bawahnya, otot, dan kemungkinan tulang, lesi kulit, dan erosi luas (Rajagukguk, 2024).

D. Pencegahan Luka Dekubitus

Upaya luka dekubitus menurut Rajagukguk (2024) antara lain:

1. Mengatur posisi yang tepat untuk mencegah terjadinya friksi.
2. Mengubah posisi setiap tiap 2 jam. Perubahan posisi tiap 2 jam disini termasuk sewaktu penderita tidur. Pada kasus-kasus tertentu, jarak waktu 2 jam masih mempunyai risiko terjadinya dekubitus.
3. Nutrisi yang baik.
4. Perawatan dan kebersihan yang baik.
5. Waspada terhadap daerah-daerah yang mempunyai risiko tinggi terbentuknya dekubitus.

Daftar Pustaka

- Rajagukguk, A. (2024). *KARAKTERISTIK RESIKO LUKA TEKAN MENGGUNAKAN SKALA BRADEN PADA PASIEN DI RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH MEDAN*.
- WHO. (2022). *Health promotion and disease prevention through population-based interventions, including action to address social determinants and health inequity*.